

# 편두통 위장 증상에 가려진 진짜 원인

소화불량·메스꺼움으로 내원한 환자에서 놓치지 말아야 할 두통

# 성인 6명 중 1명

한국인 1년 유병률 17% — 여성은 남성의 2~3배, 30~40대 가장 흔합니다

# 17%

## WHY IT MATTERS

편두통의 60~90%는 오심·구토 등 위장 증상을 동반합니다.  
환자가 두통보다 소화불량을 먼저 호소하는 경우가 흔해, 내과에서  
놓치기 쉬운 질환입니다. 정확히 진단하면 대부분 외래에서 잘  
조절됩니다.

한국 성인 1년 편두통 유병률 — 일상에서 가장 흔히 마주치는  
신경학적 질환입니다.

# 편두통이란

단순한 두통이 아니라, 뇌가 자극에 과민하게 반응하는 신경학적 질환

삼차신경혈관계 활성화와 피질 확산성 억제(CSD)가 만드는, 단순한 혈관성 두통이 아닌 뇌 자체의 과민반응입니다.

발작 사이에는 정상이지만, 한 번 발작이 시작되면 빛·소리·냄새·움직임 모든 자극이 증폭되어 느껴집니다. 위장 운동이 함께 멈추면서 오심·구토가 동반됩니다 — "체했다"고 표현하는 환자가 사실은 편두통 발작 중인 경우가 많습니다.



## TYPICAL DURATION

**4~72시간**

치료하지 않거나 부분 치료된 한 번의 발작이 지속되는 시간.

## DIAGNOSTIC THRESHOLD

**5회 이상 발작**

동일한 양상의 두통이 5회 이상 반복되면 편두통 진단을 고려합니다.

# 편두통은 종종 위장 질환처럼 옵니다

두통보다 소화 증상을 먼저 호소하는 환자가 흔합니다 — 4가지 표현 양상

## PATTERN · 01

### 전구기 위장 증상 (Prodrome)

두통 시작 **24~48시간 전** 식욕 변화, 메스꺼움, 변비 또는 설사, 갈증 — 환자는 "체할 것 같다"고 표현합니다.

## PATTERN · 02

### 위마비 (Migraine gastroparesis)

발작 중 위 배출이 **최대 78%**까지 지연됩니다. 식후 더부룩함·구토·경구약 흡수 저하 — 진통제가 듣지 않는 원인.

## PATTERN · 03

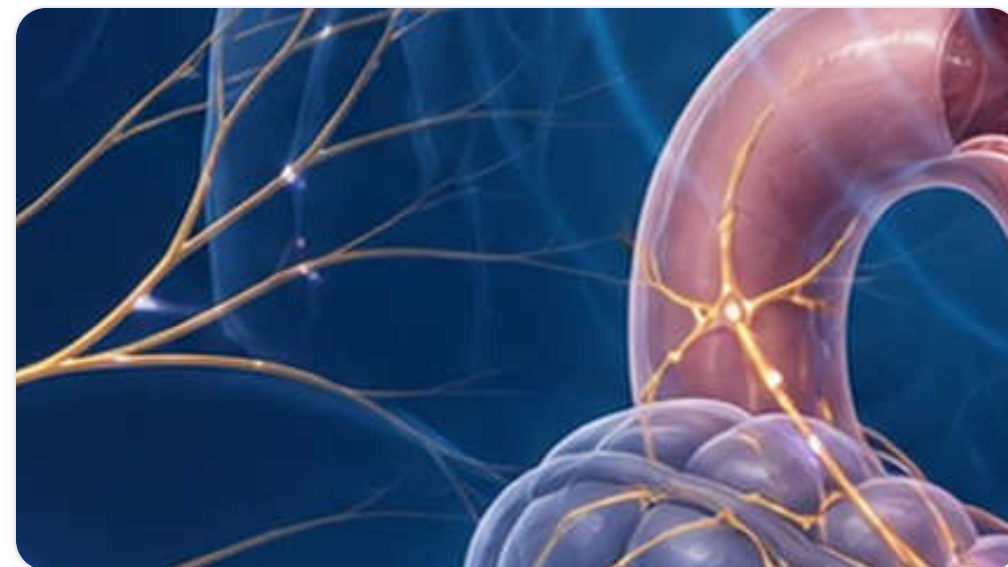
### 복부 편두통 (Abdominal migraine)

소아에 흔하나 성인도 가능. 반복적 중양 복통 + 오심·창백·식욕부진, 두통은 약하거나 없음. 내시경·복부검사 정상.

## PATTERN · 04

### 순환성 구토 증후군 (CVS)

발작적 심한 오심·구토 (수 시간~수일) → 무증상기 → 다시 반복. 편두통 스펙트럼의 일부로 본인·가족력 편두통 흔함.



## 임상 포인트

소화기 정밀검사가 정상인데 반복되는 오심·구토가 있다면, "두통이 함께 오는지" 반드시 물어보세요. 환자는 별개로 생각해 먼저 말하지 않습니다.

# 이런 환자에서 편두통을 의심하세요

위장 증상을 주소로 내원했지만, 아래 6가지 단서가 있으면 편두통 가능성

## CLUE · 01

발작적·간헐적 양상

증상이 며칠~몇 주 간격으로 반복되고 사이에 무증상기가 있습니다. 만성 위염과 다른 패턴입니다.

## CLUE · 02

검사 모두 정상

위내시경·복부초음파·혈액검사 정상인데 증상이 지속·반복. PPI·제산제 효과 미미.

## CLUE · 03

동반된 두통·머리 무거움

환자가 먼저 말하지 않더라도 "메스꺼울 때 머리도 같이 무겁지 않으세요?"라고 직접 물어보세요.

## CLUE · 04

빛·소리·냄새 과민

증상이 있을 때 어두운 방을 찾거나, 평소보다 냄새·소음이 거슬리면 강력한 단서입니다.

## CLUE · 05

가족력 — 편두통·멀미

부모·형제 편두통 또는 본인의 어린 시절 멀미·반복 복통 (소아 abdominal migraine) 병력.

## CLUE · 06

생리·날씨와 연관

여성에서 생리 주기마다 또는 기상 변화·수면 부족 후 반복된다면 편두통 패턴과 일치합니다.

# 편두통의 4단계

각 단계마다 다른 증상 — 환자가 알아채면 조기 대응이 가능합니다



# 무엇이 발작을 일으키나

개인마다 다릅니다 — 두통일기로 본인의 트리거를 파악하는 것이 핵심

## TRIGGER · 01

스트레스 · 스트레스 해소 직후

긴장이 풀린 주말·휴가 첫날 발작이 흔합니다 ("let-down headache").

## TRIGGER · 02

수면 부족 또는 과다

평소보다 적게·많이 자도 유발. 규칙적인 수면 시간이 가장 중요합니다.

## TRIGGER · 03

호르몬 변화 (여성)

생리 시작 2일 전~3일 후가 가장 흔한 발작 시점. 임신 중에는 호전, 폐경기 변동.

## TRIGGER · 04

음식 · 음료

적포도주·맥주, 숙성치즈, 가공육(아질산), MSG, 인공감미료, 카페인 금단이 흔한 유발인자.

## TRIGGER · 05

공복 · 탈수

끼니 거르기, 수분 부족도 트리거. 규칙적 식사가 예방의 기본.

## TRIGGER · 06

환경 자극

강한 빛(눈부심), 큰 소리, 향수·세제 냄새, 기압 변화·날씨 — 사전 회피가 어려운 경우도 많습니다.

# 어떻게 진단하나요

영상검사는 위험 신호 배제용 — 진단은 병력과 ICHD-3 기준으로

**ICHD-3 기준 — 두통 특성 2가지 + 동반증상 1가지가 5회 이상 반복되면 편두통입니다.**

**두통 특성 (2개 이상):** ① 한쪽 ② 박동성 ③ 중등도~심한 강도 ④ 일상 활동에 의해 악화

**동반 증상 (1개 이상):** ① 오심·구토 ② 빛·소리 과민

지속 시간 4~72시간 (치료 안 했거나 부분 치료 시). 다른 질환으로 더 잘 설명되지 않음.

## SCREENING TOOL

### ID Migraine™

3문항: 빛 과민 / 일상 지장 / 오심 — 2개 이상 "예"면 편두통 가능성 93%.

## IMAGING INDICATION

### SNOOP10 양성 시

전형적 편두통은 영상 불필요. 위험신호(다음 슬라이드) 있을 때만 MRI/CT.



# 치료 — 급성기 · 예방

발작 시 빠른 진압 + 잦은 발작은 예방 치료 병행

## ACUTE · 01

### NSAIDs · 진통제

나프록센·이부프로펜 — 경증·중등도 발작의 1차. 발작 시작 즉시 **충분량** 복용이 핵심.

## ACUTE · 02

### 트립탄 (Triptans)

수마트립탄·졸미트립탄·나라트립탄 — 중등도~중증 또는 NSAIDs 무반응 시. 오심 동반 시 비강·주사제 선택.

## ACUTE · 03

### 제토제 (Antiemetics)

메토클로프라미드·돔페리돈 — 위마비로 인한 흡수 저하 해결. 진통제와 같이 처방하면 효과 상승.

## PREVENT

### 예방 치료 적응증

**월 4회 이상** 또는 일상 지장 큰 발작 · 급성기약 효과 부족 · 약물 과용. 베타차단제·토피라메이트·CGRP 항체.

**중요** 진통제를 월 10~15일 이상 복용하면 약물과용두통(MOH)으로 두통이 만성화됩니다. "두통약을 자주 먹는다"는 환자는 반드시 빈도 확인.

# 이런 두통은 즉시 검사가 필요합니다

SNOOP10 — 이차성 두통(뇌출혈·종양·뇌수막염 등)을 시사하는 위험 신호

## RED FLAG · 01

### 벼락 두통

Thunderclap — 수초 만에 극심한 두통으로 정점에 도달. 지주막하출혈 의심, 즉시 응급실.

## RED FLAG · 02

### 50세 이후 첫 두통

늦은 나이에 처음 시작된 두통은 거대세포동맥염·종양·뇌졸중 평가가 필요합니다.

## RED FLAG · 03

### 발열·경부강직 동반

Systemic symptoms — 뇌수막염·뇌염 의심. 의식 변화 동반 시 더욱 응급.

## RED FLAG · 04

### 신경학적 결손

한쪽 마비·언어장애·시야 결손·의식 저하 — 일과성이라도 뇌졸중·TIA 평가.

## RED FLAG · 05

### 점점 심해지는 양상

며칠~몇 주에 걸쳐 강도·빈도가 progressive하게 악화. 종양·만성 경막하혈종 감별.

## RED FLAG · 06

### 자세·발살바로 악화

기침·재채기·배변 시 악화 또는 누우면 심해지는 두통 — 두개내압 변화 평가.

# 오늘부터 실천할 7가지

예방의 핵심은 규칙적 생활 + 본인의 트리거 파악

**01** 두통일기 작성 — 날짜·강도·  
유발요인·복용약

**02** 매일 같은 시각에 자고 일어나기  
(주말 포함)

**03** 끼니 거르지 않기 · 수분 1.5~2L  
섭취

**04** 카페인 일정량 유지 (갑작스러운  
증감·금단 회피)

**05** 발작 시작 즉시 처방받은 약 복용  
(참다 먹으면 효과↓)

**06** 진통제 월 10일 이하로 제한  
(약물과용두통 예방)

**07** 유산소운동 주 3회 30분 · 명상·  
요가

→ 두통일기를 다음 진료 때  
가져오세요



# 정확한 진단, 편안한 일상

증상이 변하거나 새로운 양상이 생기면 언제든지 내원해 주세요.

PHONE

**031-893-4560**

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과  
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요